

SP 1.4 — "Entre escolhas e riscos: A saúde integral do adolescente"

3ª Fase · Resumo · Saúde do Adolescente

Caso clínico

Maria Eduarda, 15 anos, chega à UBS acompanhada da amiga Ana e pede que os pais **não sejam informados** da consulta (dilema ético). Queixa-se de corrimento com odor ruim e coceira há 5 dias. Iniciou vida sexual há 6 meses, com parceiro fixo, **sem uso regular de preservativo**; nunca fez exames ginecológicos nem testes para ISTs. Relata tristeza frequente, perda de interesse escolar, conflitos com os pais, **bullying por causa do peso**, consumo ocasional de álcool, compulsão alimentar e fast food. Não recebeu as vacinas **HPV** nem **meningocócica ACWY**. Mãe com obesidade e DM2. **Exame:** IMC 28 (sobrepeso), PA 110/70, **acantose nigricans** cervical (sugere resistência insulínica), Tanner M4/P4. Ginecológico: corrimento amarelado fétido, hiperemia vaginal, **pH 5,2**, **teste das aminas (KOH) positivo**, e **clue cells** com redução de lactobacilos na microscopia a fresco.

Adolescência

ISTs

Vaginose bacteriana

Vacinação (HPV/ACWY)

Resistência insulínica

Erikson

Depressão/Bullying

Promoção da saúde

ECA / Ética

QA 1 Problemas de Saúde de Maria Eduarda (ISTs, Metabólicos, Psicossociais)

IST — Vaginose bacteriana (hipótese)

A hipótese diagnóstica é **vaginose bacteriana**: infecção causada pela falta do lactobacilo que produz peróxido de hidrogênio, permitindo o crescimento exagerado de bactérias anaeróbias — substituição da flora predominante (lactobacilo produtor de H_2O_2) por bactérias anaeróbias. O epitélio vaginal normal é a primeira linha de defesa; as células epiteliais descamadas expulsam microrganismos e fornecem nutrientes (glicose degradada pela alfa-amilase) aos lactobacilos. O **pH vaginal de 5,2** (normal: 3,8-4,5) indica aumento da flora anaeróbia, cujos produtos metabólicos provocam esfoliação do epitélio e o corrimento de cheiro desagradável.

Fatores de risco: múltiplos parceiros sexuais, falta de uso de preservativo, falta de lactobacilo vaginal e vulnerabilidade socioeconômica.

Condições metabólicas — Obesidade e síndrome metabólica

A **acantose nigricans** (escurecimento da pele, sobretudo axilas e pescoço) relaciona-se à hiperestimulação dos melanócitos pelo aumento da insulina. A **resistência periférica à insulina (RPI)** é a alteração metabólica mais comum ligada à obesidade infantil e base para outras comorbidades (HAS, dislipidemia, esteatose hepática, aterosclerose). Caracteriza-se pelo declínio na habilidade da insulina de estimular o uso de glicose por músculos e tecido adiposo e de suprimir a produção hepática de glicose. **Diagnóstico de RPI:** insulina sérica > 15 mcUI/mL ou **HOMA** (glicemia jejum/18 × insulina jejum/22,5) > 3,14. Até os 3 anos, o maior fator de risco para obesidade infantil é a presença de obesidade nos pais.

Manejo: abordagem dietética, modificação do estilo de vida, ajustes na dinâmica familiar, atividade física e apoio psicossocial. O ACSM recomenda ≥30 min de condicionamento físico (gasto ~300 kcal/sessão), 3×/semana, combinado à modificação alimentar.

Aspectos psicossociais — Álcool e depressão

Abuso de álcool: substância depressora do SNC; quanto mais precoce o uso, maior o impacto (córtex pré-frontal ainda em desenvolvimento; prejuízos dopaminérgico e límbico). Estratégias: **aconselhamento breve** (poucos minutos) e **intervenção breve** (para usuários — avaliação, reflexão sobre uso/não uso, metas, suporte social). No caso de abuso de álcool em adolescentes, a **quebra de sigilo é recomendada**, considerando o risco de morte e visando ampliar a rede de suporte.

Depressão: cerca de 25% da população mundial pode sofrer de depressão, e pelo menos metade dos episódios inicia na adolescência. Frequentemente esquecida no diagnóstico por causa de irritabilidade, sintomas flutuantes ou queixas físicas. Diagnóstico requer ≥3 sintomas: sono e apetite perturbados, impulso sexual diminuído, agitação psicomotora, retardo de ações/pensamento, dificuldade de concentração, indecisão, sentimentos de culpa/incompetência, pensamentos pessimistas e pensamentos sobre morte/suicídio. Difere do luto (que pode durar até 2 anos e geralmente não tem inibição psicomotora nem culpa inapropriada).

QA 2 ISTs na Adolescência: Diagnóstico, Tratamento e Aconselhamento

Epidemiologia e vulnerabilidade

A incidência de ISTs na adolescência associa-se a: iniciação sexual precoce, relacionamentos de duração limitada, suscetibilidade biológica, e dificuldade de acesso ao sistema de saúde. As infecções mais frequentes são por **Neisseria gonorrhoeae** e **Chlamydia trachomatis**. A maior incidência de ISTs ocorre na adolescência, atingindo até **25% dos jovens com menos de 25 anos**. Cerca de 24% das adolescentes (14-19 anos) apresentam ≥ 1 IST nos EUA (até 32% em coortes brasileiras, com clamídia a mais frequente); a incidência de ISTs (excluindo HIV) é $\sim 6.400/100.000$ adolescentes/ano. Adolescentes representam $\sim$ metade dos novos casos, apesar de serem só $\sim 1/4$ da população sexualmente ativa.

Vulnerabilidade biológica: na puberdade, o estrogênio torna o epitélio vaginal mais espesso e cornificado e aumenta o glicogênio (reduzindo o pH). A **ectopia cervical** (junção escamocolumnar exposta antes da involução) representa vulnerabilidade única à infecção em adolescentes.

Fatores de risco: idade, número de parceiros, uso de preservativo, grupo de risco, antecedente de ISTs. **Complicações:** esterilidade, gravidez ectópica, abortamentos de repetição, mortalidade perinatal.

Níveis de prevenção

- **Primária:** reduz a incidência (novos casos) — educação sexual, métodos de barreira; exceção: hepatite B e HPV, com vacina.
- **Secundária:** reduz a prevalência — identificação e tratamento imediato das infecções (incluindo os parceiros).
- **Terciária:** tratamento das complicações.

Somente o preservativo (masculino ou feminino) garante **dupla proteção** (ISTs + gravidez). O sistema de saúde deve distribuir preservativos sem barreiras e disponibilizar testes rápidos. A USPSTF recomenda aconselhamento comportamental de alta intensidade a todos os adolescentes sexualmente ativos.

Vaginite — diagnóstico diferencial

Tipo	Agente	Achados
Vaginose bacteriana	Gardnerella, Ureaplasma, Mycoplasma (não é IST, mas ligada à atividade sexual)	pH $>4,5$; teste das aminas (KOH) +; clue cells ; redução de lactobacilos
Candidíase vulvovaginal	C. albicans	

		Prurido, dor, edema, disúria; corrimento espesso e coalhado; leveduras/pseudo-hifas no KOH
Tricomoníase	T. vaginalis (protozoário)	Corrimento difuso, fétido, amarelo-esverdeado; pH elevado; T. vaginalis móvel na salina

Diagnóstico tradicional: pH + microscopia (salina 0,9% e KOH 10%). Sensibilidade da microscopia ~50%. Leucócitos sem tricomonas/leveduras sugerem cervicite. A triagem para clamídia reduziu casos de DIP em até 40%.

HPV

Mais de 100 tipos; >30 no trato genital. Maioria das infecções em adolescentes é benigna e assintomática. Maior risco: exposição a novos parceiros. A lesão mais detectada em adolescentes é a **LIEBG** (lesão intraepitelial escamosa de baixo grau — alterações benignas). Menos comum: **LIEAG** (alto grau — pré-cancerosa, rara evolução a câncer invasivo). Associado a cânceres de colo, vagina, vulva, ânus e orofaringe. **Diagnóstico:** observação das verrugas ± biópsia; Papanicolaou a partir dos 21 anos (a cada 3 anos; acima de 30, a cada 5). **Tratamento:** verrugas somem espontaneamente; persistentes → crioterapia ou ácido salicílico. **Prevenção:** vacina (antes do início da atividade sexual) e preservativo.

Hepatite B

Icterícia, hepatomegalia dolorosa, ↑ALT/AST, colestase. Incubação 45-160 dias (média ~120). Estado de carreador crônico complica até 10% dos casos adquiridos na fase adulta (persistência de HBsAg >6 meses define cronicidade). **Marcadores:** HBsAg (primeiro a aparecer; infectividade), IgM anti-HBc (marcador de infecção aguda), anti-HBs (recuperação/proteção — único presente em vacinados), HBeAg (infectividade). **Prevenção:** vacina.

QA 3 Calendário Vacinal do Adolescente (HPV e Meningocócica ACWY)

Maria Eduarda, aos 15 anos, não tomou as vacinas recomendadas aos 14 anos. Devem-se aplicar as vacinas de rotina do adolescente: **HPV**, **Meningocócica conjugada ACWY**, influenza, dengue e Covid-19. Além disso, confirmar registro de: Hepatite A e B, Febre Amarela, dT e Tríplice Viral.

HPV (calendário SBIm adolescente)

Duas vacinas disponíveis no Brasil (HPV4 e HPV9). Adolescentes previamente expostos também podem ser vacinados. Contraindicada em gestantes. No SUS: HPV4 em dose única para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Adolescentes menores de 20 anos: duas doses com intervalo de 6 meses.

Meningocócica conjugada ACWY

Para vacinados na infância: reforço aos 11 anos ou 5 anos após a última dose. Para não vacinados: a partir dos 16 anos, uma dose. Meningocócica ACWY e C não são intercambiáveis (usar a mesma).

Outras vacinas de rotina

Tríplice bacteriana (dTpa/dT), influenza (anual), dengue (Qdenga: 4-60 anos, esquema de 2 doses com intervalo de 3 meses) e Covid-19 (conforme PNI). Segundo o calendário SBP 2025/2026, adolescentes não vacinados devem receber esquemas de recuperação (ex.: Hepatite B — 3 doses; SCR/Varicela e Hepatite A — 2 doses).

QA 4 Fatores de Risco para DCNT: Obesidade e Resistência Insulínica

Fatores de risco para obesidade em Maria Eduarda: histórico familiar (obesidade e DM2 materna) e hábitos alimentares inadequados (fast food, compulsão alimentar).

O sobrepeso é fator de risco para outras DCNT porque o excesso de tecido adiposo libera **citocinas inflamatórias** que reduzem a sensibilidade à insulina e favorecem a inflamação crônica, alterando o metabolismo de glicose e lipídios. Isso leva à **resistência insulínica** — característica fisiopatológica da DM2 — evidenciada pela **acantose nigricans**, resultante da dificuldade da ação da insulina e da hiperinsulinemia compensatória.

Fatores psicossociais: o bullying pelo peso e os episódios depressivos podem agravar a compulsão alimentar e reduzir a adesão a hábitos saudáveis, além de aumentar a suscetibilidade a depressão e ansiedade a longo prazo. O **uso de álcool**, mesmo ocasional, agrava o risco de DCNT (aumento calórico → sobrepeso; interferência no metabolismo da glicose → DM2; fator de risco para depressão/ansiedade).

Diante do quadro, Maria Eduarda apresenta risco elevado de desenvolver **DM2, síndrome metabólica, doença cardiovascular e até SOP** (síndrome dos ovários policísticos).

Critérios do IDF para síndrome metabólica (10-16 anos)

Componente	Critério
Adiposidade	Circunferência abdominal $\geq$ percentil 90
Metabolismo glicêmico	Glicemia de jejum $\geq$ 100 mg/dL
Dislipidemia	Triglicerídeos $\geq$ 150 mg/dL ou HDL $\geq$ 40 mg/dL ou uso de hipolipemiantes
Hipertensão	PA $\geq$ 130 ou 85 mmHg ou uso de anti-hipertensivo

QA 5 Os Oito Estágios do Desenvolvimento Psicossocial de Erikson

Cada estágio representa um **conflito central** (crise) que, resolvido positivamente, gera uma **potencialidade (força básica/virtude)**; a não resolução gera uma **patologia básica**. A crise é uma oportunidade de desenvolvimento. Ex.: a resolução entre confiança e desconfiança gera a esperança; entre autonomia e vergonha, a vontade; e assim por diante até a sabedoria, da integridade × desespero.

Estágio (idade)	Crise psicossocial	Força básica
I — Criança (1 ano)	Confiança × Desconfiança	Esperança
II — Infância (2-3 anos)	Autonomia × Vergonha e dúvida	Vontade
III — Pré-escolar (3-5 anos)	Iniciativa × Culpa	Propósito
IV — Idade escolar (6-12 anos)	Indústria/Diligência × Inferioridade	Competência
V — Adolescência (12-20 anos)	Identidade × Confusão de identidade/papéis	Fidelidade
VI — Jovem adulto (20-30 anos)	Intimidade × Isolamento	Amor
VII — Adulto (30-50 anos)	Generatividade × Estagnação	Cuidado
VIII — Velhice (após 50 anos)	Integridade × Desespero	Sabedoria

O sucesso ou fracasso em cada estágio afeta diretamente a capacidade de resolver os conflitos seguintes; dificuldades precoces podem predispor a vulnerabilidades futuras. A resolução adequada da **identidade na adolescência** é fundamental para intimidade e generatividade na vida adulta, e a generatividade é o principal preditor da integridade na velhice. O desenvolvimento é dinâmico (possível "recuperar" estágios anteriores em contextos favoráveis). **Fatores culturais, sociais e ambientais** moldam a resolução dos conflitos: qualidade do cuidado, expectativas sociais, oportunidades educacionais, relações com pares, engajamento comunitário e atitudes culturais em relação ao envelhecimento.

QA 6 Depressão em Adolescentes: Sinais, Bullying e Acolhimento

A depressão é um problema de saúde pública crescente; cerca de 25% da população mundial pode sofrer-lá, e $\geq$ metade dos episódios inicia na adolescência. Está associada à genética e à história familiar. Frequentemente subdiagnosticada por irritabilidade, sintomas flutuantes ou queixas físicas. O DSM-5 separa transtornos depressivos e transtorno bipolar; para crianças até 12 anos com irritabilidade persistente, criou-se o **transtorno disruptivo da desregulação do humor**. A **distímia** (transtorno depressivo persistente) requer humor deprimido por ≥ 2 anos em adultos e ≥ 1 ano em crianças/adolescentes.

Quatro conjuntos de sinais e sintomas

1. **Emocionais:** tristeza, isolamento social, apatia, crises de choro, anedonia, desvalia, culpa, variação de humor.
2. **Cognitivos:** distração, dificuldade de decisão, superestimação de perdas, pessimismo, falta de esperança.
3. **Motivacionais:** indiferença a desafios, desinteresse, perda de afeição pelas pessoas, baixo rendimento escolar.
4. **Vegetativos/motores:** fadiga, retardo psicomotor, alterações de apetite/peso, insônia, perda da libido.

Na adolescência a depressão pode ser **maskada** por agitação, ataques de raiva, comportamentos delinquentes, hostilidade, autoagressão, exposição a risco, uso de drogas, dor crônica, obesidade e letargia.

Neurobiologia e tratamento

Estudos de PET/fMRI mostram diminuição de atividade do córtex pré-frontal ventral (redução de $\sim 45\%$ do volume da substância cinzenta), com conexões à amígdala, hipotálamo e núcleo accumbens. Há hiperatividade do **eixo hipotálamo-hipófise-suprarrenal** ($\uparrow$ ACTH $\rightarrow$ $\uparrow$ cortisol) em cerca de metade dos pacientes, com resistência do receptor glicocorticoide. Quimicamente, há redução na captação de serotonina. **Tratamento:** psicofármacos + psicoterapia combinados; antidepressivos mais usados: tricíclicos e ISRS (dose/tempo conforme avaliação do psiquiatra/hebiatra). A farmacogenômica (PGx) aponta para medicina personalizada. Apenas $\sim 2/3$ dos adolescentes com ansiedade/depressão acessam ajuda profissional.

QA 7 Integração de Condutas Clínicas e Promoção da Saúde na APS

- Na APS, integrar cuidado clínico e promoção da saúde, com princípios de **integralidade e longitudinalidade** e construção de vínculo entre equipe e família.
- Abordagem com **escuta qualificada** em ambiente que garanta **privacidade e sigilo**, deixando o adolescente confortável. O aconselhamento sexual deve incluir calendário vacinal, métodos de prevenção e contracepção, testes (quando cabível), avaliação de saúde mental e hábitos de vida, podendo incluir estratégias de **redução de danos**.
- Aconselhamento **livre de julgamentos** e baseado em evidências, com linguagem simples.
- **Articulação intersetorial** (especialmente com as escolas): rodas de conversa e espaços de diálogo para prevenir comportamentos de risco e atrair os adolescentes à UBS.
- Trabalho da **equipe multiprofissional** (médico, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, assistente social), garantindo a integralidade do atendimento.

QA 8 Aspectos Éticos e Legais: Sigilo, Autonomia e o ECA

O **sigilo** das informações compartilhadas no atendimento é um direito fundamental do adolescente (essencial para confiança, adesão ao tratamento e acesso a cuidados). Sua **quebra só é justificada em situações de risco iminente** à vida ou à integridade do adolescente ou de terceiros (violência, abuso, risco de suicídio, autolesão).

Quando a quebra é necessária, o profissional deve **informar o adolescente** sobre os limites do sigilo e o motivo da divulgação antes de proceder, envolvendo-o na decisão sobre como, quando e para quem a informação será compartilhada (exceto em risco iminente, quando a proteção da vida prevalece). **Protocolos:** esclarecimento prévio dos limites do sigilo, documentação adequada, avaliação de risco/consulta ética em dúvidas e comunicação transparente.

A **autonomia progressiva** permite que, em determinadas situações (saúde mental, abuso, uso de substâncias e saúde sexual), o adolescente consinta para cuidados sem autorização dos responsáveis. O respeito ao sigilo e à autonomia favorece o desenvolvimento de confiança, autoestima, independência e identidade — dialogando com os conflitos de Erikson (identidade × confusão de papéis; autonomia × vergonha).

Principais artigos do ECA

Artigo	Conteúdo
Art. 17	Direito ao respeito, privacidade e preservação de informações pessoais
Art. 11	Acesso integral às linhas de cuidado à saúde da criança e do adolescente pelo SUS, com equidade (Lei nº 13.257/2016)
Art. 245	Dever do médico/professor/responsável de comunicar à autoridade competente casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos (multa de 3 a 20 salários de referência, dobrada em reincidência)

Referências bibliográficas citadas na fonte

- KLIEGMAN, R. M.; ST. GEME, J. W. (eds.). **Nelson Tratado de Pediatria**. 21. ed. Rio de Janeiro: GEN Guanabara Koogan, 2022.
- SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Tratado de Pediatria**. 6. ed. Barueri: Manole, 2025. v. 2.
- MORAIS, M. B. de; CAMPOS, S. de O.; HILÁRIO, M. O. E. **Pediatria: Diagnóstico e Tratamento**. Barueri: Manole, 2013.
- SANTOS, E. P.; COSTA, A. A. Z. **Cuidado integral à saúde do adolescente**. Porto Alegre: SAGAH, 2019.
- AZEVEDO, A. E. B. I.; REATO, L. F. N. **Manual de Adolescência**. Barueri: Manole, 2019.
- Calendário de Vacinação SBIm Adolescente 2024/2025; Calendário de Vacinação SBP 2025/2026.
- BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. **Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)**. Brasília: MMFDH, 2021.

BORDIGNON, N. A. El desarrollo psicosocial del joven adulto en Erik Erikson. *Revista Lasallista de Investigación*, 2007. + artigos sobre desenvolvimento psicossocial (Vaillant, Whitbourne, Kivnick, Marcia) e confidencialidade na adolescência (Chung, Breuner, Kafka — *Pediatrics/J. Clin. Med.*, 2023-2024).